

Demenz im Krankenhaus

Zwei Doppelstunden – Basismaterial zur weiteren Ausarbeitung

Was erlebt ein Mensch mit Demenz,
wenn er plötzlich Patient im Krankenhaus wird?

Worum geht es?

- Besondere Belastungen eines Krankenhausaufenthalts für Menschen mit Demenz verstehen
- Verhalten aus der Perspektive der betroffenen Person betrachten
- Pflegerische Handlungsmöglichkeiten für eine demenzsensible Versorgung ableiten
- Akute Veränderungen wahrnehmen und an ein mögliches Delir denken

Eigene Erfahrungen

- Welche Erfahrungen mit Menschen mit einer Demenz haben Sie während ihrer Krankenhaus- Einsätze machen können?

Menschen:

zeigen sich ängstlich,

klingeln häufig,

fragen häufig nach,

verweigern Medikamente oder notwendige Untersuchungen,

sind unruhig usw.

Woran könnte das liegen?

- Leitsymptome einer Demenz:

Vergesslichkeit (immer wieder nachfragen)

Orientierungsstörung

- zeitlich
 - örtlich
 - situativ
 - zur Person
- Gewohnte Umgebung, gewohnte Abläufe und Personen sind besonders wichtig, wenn es mir schwerfällt mich zu orientieren und neue Situationen kognitiv zu erfassen

Fallbeispiel: Herr Werner

- 82 Jahre, Alzheimer-Demenz seit etwa drei Jahren
- lebt mit seiner Ehefrau zu Hause und orientiert sich stark an festen Gewohnheiten
- Sturz zu Hause – starke Schmerzen im rechten Bein
- Rettungsdienst, Notaufnahme, Röntgen: hüftnahe Fraktur
- Aufnahme auf eine unfallchirurgische Station

„Der Herr Werner ist heute wirklich schwierig.“

„Er klingelt ständig und versteht einfach nicht,
dass er im Bett bleiben muss.“

„Er hat eben Demenz. Da kann man wahrscheinlich
nicht viel machen.“

Demenz im Krankenhaus – Doppelstunde 2

Vom Verstehen des Verhaltens zum professionellen pflegerischen Handeln

Wenn wir verstehen, warum Herr Werner sich so verhält:
Was folgt daraus für unser pflegerisches Handeln?

Wo stehen wir?

- Menschen mit Demenz erleben die ungewohnte Krankenhaussituation häufig als belastend.
- Vergesslichkeit führt dazu, dass Informationen immer wieder verloren gehen.
- Zeitliche, örtliche, situative und personenbezogene Orientierungsstörungen erschweren das Verstehen der Situation.
- Angst, häufiges Nachfragen, Klingeln, Unruhe oder Abwehr können vor diesem Hintergrund nachvollziehbar werden.

Auswertung des Falls: Herr Werner

Was erlebt Herr Werner – und was trägt im Krankenhaus dazu bei?

- Welche Situationen lösen vermutlich Angst, Unsicherheit oder Überforderung aus?
- Welche Bedürfnisse könnten hinter seinem Verhalten stehen?
- Welche Bedingungen des Krankenhauses verstärken seine Schwierigkeiten?
- Welche Reaktionen der Mitarbeitenden sind hilfreich – welche eher nicht?

„Schwieriger Patient“ – oder herausgeforderter Mensch?

Verhalten entsteht nicht im luftleeren Raum.

- Demenzbedingte Einschränkungen treffen auf eine fremde und komplexe Umgebung.
- Schmerz, Angst, fehlende Orientierung und unverstandene Handlungen können Verhalten beeinflussen.
- Die zentrale Frage lautet deshalb nicht nur: „Wie stoppen wir das Verhalten?“
- Sondern: „Was braucht dieser Mensch in dieser Situation?“

Demenzsensible Pflege: vier Ansatzpunkte

Orientierung

Umgebung und Abläufe verständlicher machen

Kommunikation

Sicherheit geben und Verstehen ermöglichen

Biografie & Angehörige

Vertrautes Wissen gezielt nutzen

Körperliche Bedürfnisse

Schmerz, Hunger, Durst, Ausscheidung, Schlaf beachten

Orientierung unterstützen

- wiederholt erklären, wo die Person ist und was als Nächstes geschieht
- Informationen sichtbar und verständlich anbieten
- möglichst verlässliche Abläufe und Bezugspersonen schaffen
- unnötige Reize und häufige Ortswechsel vermeiden
- Brille, Hörgerät und andere Hilfsmittel verfügbar machen
- vertraute Gegenstände oder Fotos nutzen, wenn dies hilfreich ist

Kommunikation: weniger erklären – besser erreichen

- Kontakt herstellen, Blickkontakt ermöglichen und sich vorstellen
- kurze, konkrete Sätze und jeweils eine Information verwenden
- Zeit zum Verstehen und Antworten lassen
- Informationen ruhig wiederholen statt auf das Erinnern zu bestehen
- Gefühle hinter einer Aussage wahrnehmen und ernst nehmen
- bekannte Prinzipien der Integrativen Validation auf die Situation übertragen

Was antworten Sie Herrn Werner?

„Wo ist meine Frau? Ich muss nach Hause!“

- Welche Antwort wäre fachlich wenig hilfreich?
- Wie könnte eine demenzsensible Reaktion aussehen?
- Was könnte Herr Werner in diesem Moment eigentlich brauchen?

Biografie und Angehörige

Angehörige sind nicht nur Besuch – sie können wichtige Informationen liefern.

- Welche Gewohnheiten geben Sicherheit?
- Was beruhigt oder verunsichert die Person?
- Wie äußert sie normalerweise Schmerzen oder andere Bedürfnisse?
- Welche Themen, Personen oder Tätigkeiten sind vertraut?
- Welche Informationen sollten möglichst alle beteiligten Mitarbeitenden kennen?

Körperliche Ursachen mitdenken

- Schmerz
- Hunger und Durst
- Harndrang, Obstipation oder andere Ausscheidungsprobleme
- Schlafmangel und Erschöpfung
- Infektionen oder andere akute Erkrankungen
- Nebenwirkungen bzw. Veränderungen der Medikation

Nicht jedes auffällige Verhalten ist unmittelbar „die Demenz“.

Fallfortsetzung: Herr Werner in der Nacht

- Herr Werner wirkt plötzlich deutlich unruhiger als am Nachmittag.
- Er ruft nach Personen, die nicht im Zimmer sind.
- Seine Aufmerksamkeit schwankt stark; zeitweise lässt er sich kaum ansprechen.
- Später ist er ungewöhnlich schläfrig.
- Am nächsten Morgen wirkt er erneut stark unruhig und desorientiert.

Was ist hier anders?

Welches typische Demenzsymptom erklärt diese plötzliche Veränderung?

Oder müssen wir an etwas anderes denken?

Demenz oder Delir?

Demenz

- meist schleichender Beginn
- längerfristiger Verlauf
- kognitive Einschränkungen bestehen dauerhaft

Delir

- akuter Beginn
- häufig schwankender Verlauf
- Aufmerksamkeit und Bewusstsein können deutlich verändert sein

Ein Delir kann zusätzlich zu einer bestehenden Demenz auftreten.

Wichtige Konsequenz für die Pflege

Eine plötzliche Veränderung darf nicht einfach mit „Er hat eben Demenz“ erklärt werden.

- Veränderungen aufmerksam beobachten und beschreiben
- körperliche Ursachen mitdenken
- Informationen im Team weitergeben
- eine zeitnahe medizinische Abklärung veranlassen

Arbeitsauftrag: Herr Werner demenzsensibel versorgen

- Wählen Sie eine problematische Situation aus dem Fall.
- Beschreiben Sie die Situation zunächst aus Sicht von Herrn Werner.
- Formulieren Sie ein pflegerisches Ziel.
- Entwickeln Sie konkrete Maßnahmen zu Orientierung, Kommunikation, Umgebung und Sicherheit.
- Begründen Sie Ihre Maßnahmen.

Ergebnissicherung

Was braucht ein Mensch mit Demenz im Krankenhaus?

- Orientierung
- Sicherheit und Beziehung
- verständliche Kommunikation
- möglichst vertraute Strukturen
- Beachtung individueller Bedürfnisse
- aufmerksame Beobachtung bei Veränderungen

Zum Mitnehmen

Verhalten verstehen.
Bedürfnisse erkennen.
Umgebung und Pflege anpassen.

Und bei plötzlichen Veränderungen:
Nicht vorschnell die Demenz verantwortlich machen.